

## OMS - Santé mentale des adolescents

Une personne sur six est âgée de 10 à 19 ans. L'adolescence est une période très particulière et déterminante. Les changements physiques, émotionnels et sociaux, ainsi que la pauvreté, la maltraitance ou la violence, peuvent rendre les adolescentes et les adolescents vulnérables aux troubles mentaux. Pour que les adolescentes et les adolescents soient en bonne santé et se sentent bien pendant cette étape de leur vie puis à l'âge adulte, il faut absolument éviter qu'ils tombent dans des écueils, mettre en avant l'apprentissage socioaffectif et le bien-être psychologique et leur garantir un accès aux soins de santé mentale.

À l'échelle mondiale, on estime qu'un jeune de 10 à 19 ans sur sept (14 %) souffre de troubles mentaux (1) ; pourtant, en général, ces troubles sont négligés et ne sont pas traités.

Les adolescentes et les adolescents souffrant de troubles mentaux sont particulièrement exposés à l'exclusion sociale, à la discrimination, à la stigmatisation (ce qui joue sur la mesure dans laquelle ils sont disposés à demander de l'aide), aux difficultés éducatives, aux comportements à risque, aux problèmes de santé physique et aux violations des droits humains.

L'adolescence est une période cruciale pour l'adoption d'habitudes sociales et émotionnelles importantes pour le bien-être mental. Il s'agit notamment pour les adolescentes et les adolescents d'adopter des rythmes de sommeil sains, d'avoir une activité physique régulière, de développer leurs capacités d'adaptation, et d'apprendre à résoudre des problèmes, à nouer des relations et à gérer leurs émotions. Un environnement protecteur et favorable au sein de la famille, en milieu scolaire et dans la communauté en général joue également un rôle.

De multiples facteurs ont une influence sur la santé mentale. Plus les facteurs de risque sont nombreux, plus l'impact potentiel sur la santé mentale est important. Parmi les facteurs qui peuvent contribuer au stress à l'adolescence, il y a l'adversité, la pression pour se conformer à ses pairs et l'exploration de l'identité. L'influence des médias et les normes de genre peuvent exacerber le décalage entre la réalité vécue par un adolescent et ses perceptions ou aspirations pour l'avenir. D'autres déterminants importants de la santé mentale des adolescents sont la qualité de leur vie familiale et leurs relations avec leurs pairs. On sait que la violence (en particulier la violence sexuelle et le harcèlement), une éducation sévère, les problèmes graves et les difficultés socioéconomiques font peser un risque sur la santé mentale.

Certains adolescents et certaines adolescentes risquent davantage de souffrir de troubles mentaux en raison de leurs conditions de vie, de la stigmatisation, de la discrimination ou de l'exclusion, ou encore du manque d'accès à un accompagnement et à des services de qualité. Il s'agit notamment des adolescentes et des adolescents vivant dans des situations de crise humanitaire et de fragilité ; des adolescentes et des adolescents souffrant de maladies chroniques, de troubles du spectre autistique, d'un handicap intellectuel ou d'autres troubles neurologiques ; des adolescentes enceintes, des parents adolescents ou des adolescentes et adolescents mariés de force ou à un âge précoce ; des orphelines et orphelins ; ainsi que des adolescentes et adolescents issus de minorités ethniques ou sexuelles ou d'autres groupes victimes de discrimination.

Les troubles émotionnels sont fréquents chez les adolescentes et les adolescents. Les troubles anxieux (qui peuvent prendre la forme d'un trouble panique ou d'une inquiétude excessive) sont les plus répandus dans cette tranche d'âge et sont plus fréquents chez les adolescentes et adolescents plus âgés. On estime que 4,1 % des 10-14 ans et 5,3 % des 15-19 ans souffrent d'un trouble anxieux (1) . On estime que la

dépression touche 1,3 % des adolescentes et des adolescents âgés de 10 à 14 ans et 3,4 % de celles et ceux âgés de 15 à 19 ans (1) . Certains symptômes sont communs à la dépression et à l'anxiété, notamment les variations rapides et inattendues de l'humeur.

L'anxiété et les troubles dépressifs peuvent avoir de graves répercussions sur l'absentéisme et le travail scolaires. Le repli sur soi peut exacerber l'isolement et la solitude. La dépression peut conduire au suicide.

Les troubles du comportement sont plus fréquents chez les jeunes adolescentes et adolescents. Le trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH) concerne 2,7 % des jeunes de 10 à 14 ans et 2,2 % des jeunes de 15 à 19 ans (1) , qui ont du mal à fixer leur attention et/ou ont un comportement caractérisé par une activité excessive et agissent sans tenir compte des conséquences. Le trouble des conduites (dont les comportements destructeurs ou provocateurs sont un symptôme) touche 3,3 % des jeunes âgés de 10 à 14 ans et 1,8 % des jeunes âgés de 15 à 19 ans (1) . Les troubles du comportement peuvent avoir des conséquences sur l'éducation et augmentent le risque de commettre des délits.

Les troubles de l'alimentation, tels que l'anorexie mentale et la boulimie, apparaissent généralement à l'adolescence et au début de l'âge adulte. Ils se traduisent par un comportement alimentaire anormal et une préoccupation excessive pour la nourriture, accompagnée dans la plupart des cas d'inquiétudes concernant le poids et la forme du corps. Les filles sont plus souvent touchées que les garçons. Les troubles de l'alimentation peuvent avoir une incidence sur la santé physique et sont souvent concomitants de la dépression, de l'anxiété et des troubles liés à la consommation de substances. On estime qu'ils touchent 0,1 % des 10-14 ans et 0,4 % des 15-19 ans (1) . Ils sont associés au suicide. L'anorexie mentale peut entraîner une mort prématurée, souvent due à des complications ou au suicide, et elle est associée à une mortalité plus élevée que n'importe quel autre trouble mental.

Les troubles qui se manifestent par des symptômes psychotiques, notamment des hallucinations ou des idées délirantes, apparaissent le plus souvent à la fin de l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Les expériences psychotiques peuvent avoir une incidence sur la vie quotidienne et la scolarité, et sont souvent source de stigmatisation ou de violations des droits humains. La schizophrénie touche 0,1 % des 15-19 ans (1) .

Le suicide est la troisième cause de décès chez les grands adolescents et les jeunes adultes (15-29 ans) (2) . Les facteurs de risque de suicide sont multiples : usage nocif de l'alcool, maltraitance pendant l'enfance, stigmatisation à l'encontre des personnes qui cherchent de l'aide, obstacles à l'accès aux soins et accès aux moyens permettant de passer à l'acte. Les médias numériques, comme tout autre média, peuvent jouer un rôle important aussi bien pour renforcer que pour affaiblir les initiatives de prévention du suicide.

De nombreux comportements à risque pour la santé, comme la consommation de substances psychoactives ou certains comportements sexuels, commencent à l'adolescence. Les comportements à risque peuvent à la fois constituer une stratégie inefficace pour faire face à des difficultés émotionnelles et avoir de graves conséquences sur le bien-être mental et physique d'un adolescent.

Les jeunes sont particulièrement vulnérables à l'adoption de modes de consommation de substances nocives qui peuvent persister tout au long de la vie. En 2019, la prévalence de la consommation d'alcool chez les 15-19 ans était élevée partout dans le monde (22 %), et on constatait très peu de différences entre les genres ainsi qu'une augmentation de la consommation dans certaines Régions (3) .

La consommation de tabac et de cannabis est également préoccupante. De nombreux fumeurs adultes ont pris leur première cigarette avant l'âge de 18 ans. En 2022, la prévalence de la consommation de cannabis

chez les adolescentes et les adolescents était plus élevée que chez les adultes au niveau mondial (5,5 % contre 4,4 %, respectivement) (4) .

La perpétration d'actes violents est un comportement à risque qui peut accroître la probabilité de décrochage scolaire, de traumatismes, de participation à des activités délictueuses ou de décès. La violence interpersonnelle a été classée parmi les principales causes de décès chez les grands adolescents en 2021 (1) .

Les interventions de promotion de la santé mentale et de prévention visent à renforcer la capacité de chacune et chacun à gérer ses émotions, à trouver davantage de solutions alternatives aux comportements à risque, à devenir plus résilient afin de faire face à des situations difficiles ou à l'adversité, et à promouvoir des environnements et des réseaux sociaux bienveillants.

Ces programmes nécessitent d'adopter une approche à plusieurs niveaux avec différentes plateformes de diffusion ? par exemple les médias numériques, les établissements de soins de santé, les services sociaux, les établissements scolaires ou la communauté ? de même que différentes stratégies pour toucher les adolescentes et les adolescents, en particulier les plus vulnérables.

Il est fondamental de répondre aux besoins des adolescentes et des adolescents présentant des troubles mentaux. Ainsi, il faut éviter le placement en institution et la surmédicalisation des adolescents, donner la priorité aux approches non pharmacologiques et respecter les droits de l'enfant conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et aux autres instruments relatifs aux droits humains.

L'OMS s'emploie à mettre sur pied des stratégies, des programmes et des outils afin d'aider les gouvernements à répondre aux besoins de santé des adolescentes et des adolescents.

Par exemple, l'initiative HAT (« Helping Adolescents Thrive » ou « aider les adolescents à s'épanouir ») est une action menée conjointement par l'OMS et l'UNICEF afin de renforcer les politiques et les programmes en faveur de la santé mentale des adolescentes et des adolescents. Plus précisément, les efforts déployés dans le cadre de l'initiative visent à promouvoir la santé mentale et à prévenir les troubles mentaux. L'objectif est également de contribuer à prévenir l'automutilation et d'autres comportements à risque, tels que l'usage nocif de l'alcool et des drogues, qui ont des conséquences négatives sur la santé mentale - et physique - des jeunes.

L'OMS a également élaboré un module sur les troubles mentaux et les troubles du comportement chez l'enfant et l'adolescent dans le cadre de la version 2.0 du Guide d'intervention mhGAP. Ce guide propose des protocoles cliniques reposant sur des bases factuelles pour évaluer et prendre en charge un éventail de troubles mentaux dans des établissements de soins non spécialisés.

En outre, l'OMS élabore et met à l'essai des interventions psychologiques adaptables visant à traiter les troubles émotionnels des adolescentes et des adolescents, ainsi que des orientations sur les services de santé mentale pour adolescents.

Le Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale a conçu un programme de formation en santé mentale à l'intention du personnel enseignants pour qu'il comprenne mieux combien la santé mentale est importante dans les établissements scolaires ; l'objectif est également d'orienter la mise en œuvre de stratégies visant à promouvoir, protéger et rétablir la santé mentale chez les élèves. Cette formation s'appuie sur des manuels et du matériel pour accroître le nombre d'établissements scolaires faisant la promotion de la santé mentale.

- (1) 2021 Global Burden of Disease (GBD) [base de données en ligne]. Seattle: Institute for Health Metrics and Evaluation; 2024 (<https://vizhub.healthdata.org/gbd-results/>, consulté le 13 août 2025).
- (2) WHO Global Health Estimates 2000-2021
- (3) Global status report on alcohol and health and treatment of substance use disorders. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2024.
- (4) World Drug Report. Genève, ONUDC, 2024